

УДК 616-006-07

А.Р. Бейсенаева, В.Б. Сирота, Д.Д. Дороган, А.А. Уйсин

Карагандинский государственный медицинский университет

ОПЕРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ БЕЗ ПЕРВИЧНО-ВЫЯВЛЕННОГО ОЧАГА НА ФОНЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ

Аннотация. Для оценки качества жизни пациенты были анкетированы с помощью опросника «Опросник для определения качества жизни инкурабельных пациентов на фоне проведения химиотерапии (QLQ-IP-CC)» (Бейсенаева А.Р., Сирота В. Б., 2016 ©). Анкетированию были подвергнуты 70 пациентов с опухолями без первично-выявленного очага. Математически показано, что при показателе качества жизни, равного 6-7 баллов, и при возрастании интенсивности боли на 1-2 балла дальнейшее проведение паллиативной химиотерапии нецелесообразно, т.к. данные показатели наиболее наглядно позволяют судить об эффективности проведения химиотерапии пациентам.

Ключевые слова: опухоли без первично-выявленного очага, паллиативная химиотерапия, качество жизни.

Введение. Трудной задачей в паллиативной химиотерапии является выбор оптимальной тактики лечения - преодоление дилеммы проведения эффективной терапии во избежании токсических последствий. Необходимое больному высокое «качество жизни» требует редукции основных клинических проявлений метастатического ракового процесса, что возможно лишь путем проведения эффективной химиотерапии, которая в свою очередь приводит к возникновению ряда нежелательных побочных явлений [1,2]. В поисках оптимального поддержания необходимого баланса между проявлениями самой болезни и побочными симптомами лечения часто приходится корректировать схемы лечения. К сожалению, изменение схем химиотерапии, в основном, происходит индивидуально, без весомых обоснований, поскольку определенных критериев и методик по модифицированию режимов паллиативной химиотерапии не существует [3,4].

Цель исследования - оценить показатели боли и качества жизни у пациентов с опухолями без первично-выявленного очага на фоне проведения паллиативной химиотерапии.

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на базе КГП «Областной онкологический диспансер» г. Караганды в период с 2006 по 2014 гг. и отделения паллиативной помощи клинической больницы г. Лодзь (Польша). Все пациенты были полностью обследованы и диагноз верифицирован с помощью иммуногистохимического исследования биоптата. Для оценки качества жизни пациенты были анкетированы с помощью опросника «Опросник для определения качества жизни

инкурабельных пациентов на фоне проведения химиотерапии (QLQ-IP-CC)» (Бейсенаева А.Р., Сирота В. Б., 2016 ©) [5]. QLQ-IP-CC состоит из двух разделов: паспортная часть и опросник оценки качества жизни. Первый раздел содержит 4 вопроса открытого типа о пациенте и получаемом лечении. Вопрос №1 повествует об инициалах пациента. Вопрос №2 - полный возраст. Вопрос №3 содержит информацию о курсе химиотерапии. Вопрос №4 - дата заполнения.

Второй раздел представлен опросником для определения качества жизни инкурабельных пациентов на фоне проведения химиотерапии в виде таблицы. Таблица состоит из трех столбцов: 1) возможных жалоб (ощущений) пациента до и после специального лечения; 2) интенсивность (от 0 до 10) данных жалоб (ощущений) до химиотерапии; 3) интенсивность (от 0 до 10) этих же жалоб (ощущений) через неделю после курса химиотерапии.

Среди возможных жалоб (ощущений) пациента представлены следующие: боль, тошнота, рвота, запор, диарея, снижение аппетита, кашель, одышка, нарушения сна, чувство беспокойства, чувство напряженности, слабость после физической деятельности (прогулка, занятие домашними делами), усталость, снижение внимания и памяти, необходимость в посторонней помощи, оценка здоровья и качества жизни в целом.

Анкетированию были подвергнуты 70 пациентов с опухолями без первично-выявленного очага. Пациенты заполняли анкету накануне назначенного курса химиотерапии и через неделю после его окончания. Например, пациент заполнял анкету до 1-го курса ПХТ, через 1 неделю ответил на пункты второй колонки опросника; придя через 3 недели на 2-й курс ПХТ, заполнял анкету вновь и т.д. Для объективизации приведена шкала от 1 до 10 баллов, где 1 - отсутствие признаков, 10 - невозможность выполнять вид деятельности из-за наличия болевого синдрома или снижения качества жизни.

Полученные данные анкет были обработаны компьютерной программой «STATISTICA 6.0».

Результаты исследования. Сравнение параметров качества жизни до и после химиотерапии по опроснику QLQ-IP-CC проводилось по медианным значениям с учетом верхних и нижних квартилей.

Медианные значения до проведения химиотерапии таких признаков, как тошнота, рвота, одышка, нарушения сна, усталость, необходимость в посторонней помощи, нарушения внимания и памяти колебались в пределах от 1,0 до 2,0. Доверительные интервалы медианных по-

казателей до проведения химиотерапии запор, диарея, кашель, колебались в пределах от 1,0 до 1,0. Доверительные интервалы таких признаков, как боль колебались от 1,0 до 5,0, снижение аппетита – от 1,0 до 3,0, слабость – от 1,0 до 2,5. Беспокойство и напряжение были в пределах от 2,0 до 3,0, здоровье и качество жизни – от 7,0 до 9,0.

Доверительные интервалы медианных значений после проведения химиотерапии таких признаков, как нарушения сна, беспокойство, напряжение, необходимость в посторонней помощи колебались в пределах от 2,0 до

3,0. Такие признаки, как кашель и запор были в пределах от 1,0 до 1,0, одышка и диарея – от 1,0 до 2,0. Доверительные интервалы таких признаков, как боль, колебались от 1,0 до 3,5, тошнота – от 2,0 до 3,5, слабость – от 3,0 до 5,0, здоровье в целом – от 7,0 до 8,0, качество жизни – от 5,5 до 8,0, снижение аппетита – от 1,0 до 3,0, слабость – от 1,0 до 2,5. Рвота и снижение памяти и внимания колебались от 1,0 до 3,0, усталость и снижение аппетита – от 2,0 до 4,0 (таблица 1).

Таблица 1 – Параметры опросника QLQ-IP-CC до и после паллиативной химиотерапии по медианным значениям с учетом верхних и нижних квартилей

Номер	Признак	до ПХТ		после ПХТ	
		Me	25-75% ДИ	Me	25-75% ДИ
1	Боль	4,0	1,0:5,0	2,0	1,0:3,5
2	Тошнота	1,0	1,0: 2,0	2,0	2,0:3,5
3	Рвота	1,0	1,0: 2,0	2,0	1,0: 3,0
4	Запор	1,0	1,0: 1,0	1,0	1,0: 1,0
5	Диарея	1,0	1,0: 1,0	1,0	1,0: 2,0
6	Снижение аппетита	2,0	1,0:3,0	3,0	2,0: 4,0
7	Кашель	1,0	1,0: 1,0	1,0	1,0: 1,0
8	Одышка	1,0	1,0: 2,0	1,0	1,0: 2,0
9	Нарушения сна	2,0	1,0: 2,0	2,0	2,0: 3,0
10	Беспокойство	2,0	2,0:3,0	2,0	2,0: 3,0
11	Напряжение	2,0	2,0:3,0	2,0	2,0: 3,0
12	Слабость	2,0	1,0:2,5	4,0	3,0:5,0
13	Усталость	2,0	1,0: 2,0	3,0	2,0: 4,0
14	Снижение памяти, внимания	1,0	1,0: 2,0	2,0	1,0: 3,0
15	Необходимость в помощи	2,0	1,0: 2,0	2,0	2,0: 3,0
16	Здоровье	8,0	7,0:9,0	7,0	7,0:8,0
17	Качество жизни	8,0	7,0:9,0	7,0	5,5:8,0

По совокупности 17-ти вопросов построены диаграммы размаха, которые отражают качество и вариабельность вариантов ответов на вопросы.

На рисунке 1 хорошо виден диапазон колебаний ответов пациентов на вопросы опросника до химиотерапии и после нее. Такой признак, как боль до химиотерапии имеет больший диапазон колебаний, чем боль после

химиотерапии. Тошнота и рвота до химиотерапии имели заметно больший диапазон размаха, нежели после проведения химиотерапии. Такой признак, как запор имеет более узкий диапазон колебаний. Диарея до химиотерапии характеризуется минимальным размахом по сравнению с диареей после курса химиотерапии (рисунок 1).

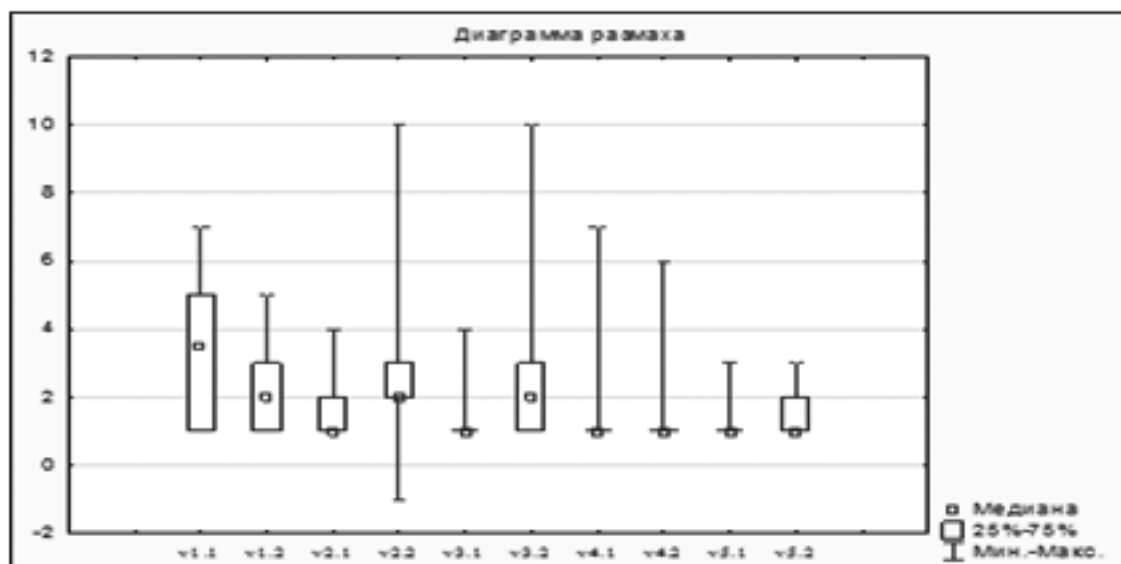


Рисунок 1 – Соотношение частоты совпадения такими показателями, как боль, тошнота, рвота, запор, диарея до и после химиотерапии

На рисунке 2 показан диапазон колебаний ответов пациентов по таким показателям, как снижение аппетита, кашель, одышка, нарушения сна, беспокойство до и после химиотерапии. Такой признак, как нарушение сна имел заметно больший диапазон размаха до, нежели после проведения химиотерапии. Кашель до химиоте-

рапии имеет меньший диапазон колебаний, чем после химиотерапии. Частота проявления одышки, снижения аппетита до и после химиотерапии практически не изменились. Беспокойство до химиотерапии характеризуется немного меньшим размахом, нежели после нее.

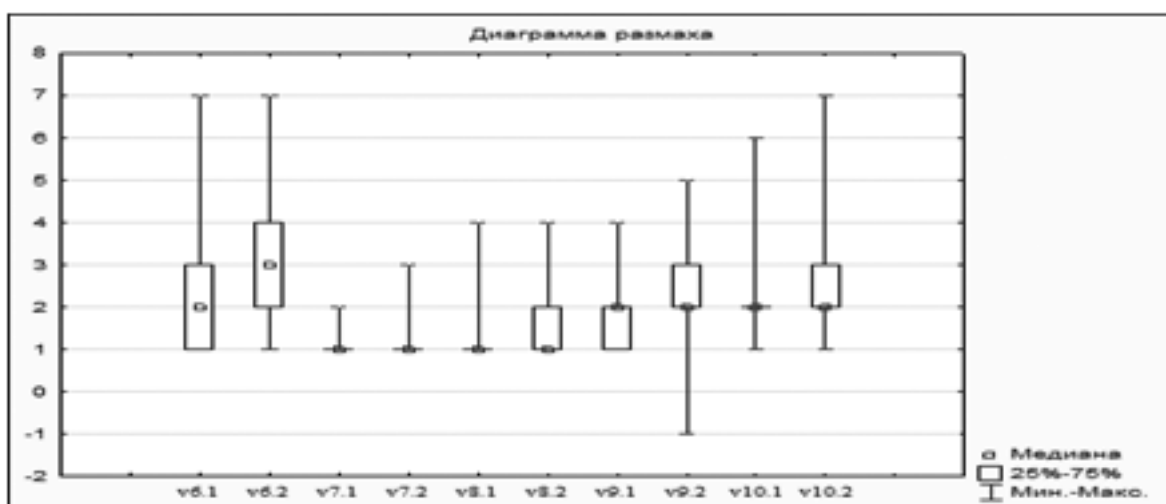


Рисунок 2 – Соотношение частоты совпадения такими показателями, как снижение аппетита, кашель, одышка, нарушения сна, беспокойство до и после химиотерапии

На рисунке 3 представлен диапазон колебаний таких показателями, как напряжение, слабость, усталость, снижение внимания и памяти, необходимость в посторонней помощи, здоровье и качество жизни в целом. Такой признак, как усталость до химиотерапии имеет больший диапазон колебаний, чем после химиотерапии. Необходимость в посторонней помощи до химиоте-

рапии характеризуется меньшим размахом по сравнению с необходимостью в посторонней помощи после курса химиотерапии. Такие показатели, как здоровье в целом и качество жизни пациента до химиотерапии имели заметно меньший диапазон размаха, нежели после проведения химиотерапии.

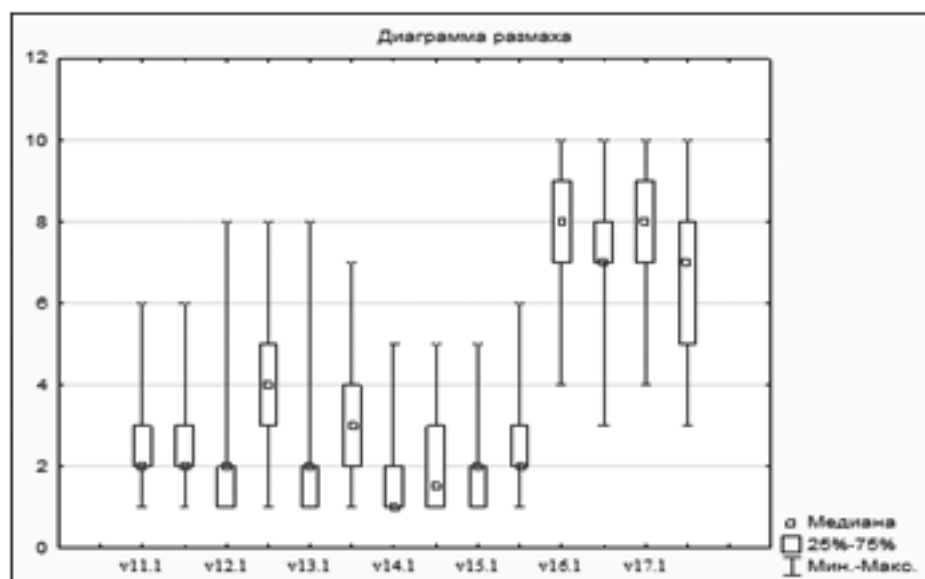


Рисунок 3 – Соотношение частоты совпадения такими показателями, как напряжение, слабость, усталость, снижение внимания и памяти, необходимость в посторонней помощи, здоровье и качество жизни в целом

Таким образом, используя медианные значения с учетом верхних и нижних квартилей для определения качества жизни пациентов с опухолями без первично-выявленного очага на фоне проведения паллиативной химиотерапии общее качество жизни заметно снижается за счет таких параметров, как тошнота (1,0:2,0), рвота (1,0:2,0), снижение аппетита (2,0:3,0), слабость (2,0:4,0), усталость (2,0:3,0), снижение памяти (1,0:2,0), нарушение сна (2,0:2,0), беспокойство (2,0:2,0), необходимость в посторонней помощи (2,0:2,0).

Такие показатели, как боль и качество жизни в целом наиболее наглядно позволяют судить об эффективности проведения химиотерапии пациентам.

Все пациенты получали от 1 до 4-х курсов паллиативной химиотерапии. На первом курсе химиотерапии средний балл интенсивности болевого синдрома составил $2,65 \pm 0,38$, на втором – $3,05 \pm 0,40$, на третьем – $3,83 \pm 0,44$, на четвертом – $4,11 \pm 0,51$ (таблица 2). Как видно из таблицы 1, интенсивность боли с каждым последующим курсом химиотерапии возрастает, т.е. эффективность химиотерапии в отношении параметра боли снижается с каждым курсом.

Таблица 2 - Оценка интенсивности боли у пациентов с опухолями без первично-выявленного очага на фоне проведения химиотерапии

Курс ПХТ	Число наблюдений	М среднее, баллы	Ошибка среднего m, %	Диапазон колебания	
				95% ДИв	95% ДИН
1	23	2,65	0,38	1,86	3,44
2	19	3,05	0,40	2,21	3,89
3	18	3,83	0,44	2,89	4,77
4	10	4,11	0,51	2,92	5,29

Параллельно провели сравнение с показателем качества жизни в целом.

На первом курсе химиотерапии средний балл показателя качества жизни у пациентов составил $8,69 \pm 0,19$, на втором – $8,00 \pm 0,32$, на третьем – $7,11 \pm 0,23$, на четвертом

– $6,33 \pm 0,37$ (таблица 3). Как видно из таблицы 2, качество жизни с каждым последующим курсом химиотерапии падает, т.е. эффективность химиотерапии в отношении параметра качества жизни пациента также снижается с каждым курсом.

Таблица 3 - Оценка качества жизни в целом у пациентов с опухолями без первично-выявленного очага на фоне проведения химиотерапии

№	Курс ПХТ	Число наблюдений	М сред нее, баллы	Ошибка среднего т, %	Диапазон колебания	
					95% ДИв	95% ДИн
1	1	23	8,69	0,19	8,29	9,09
2	2	19	8,00	0,32	7,32	8,68
3	3	18	7,11	0,23	6,63	7,59
4	4	10	6,33	0,37	5,47	7,19

Различие между показателями качества жизни перед 3-м и перед 4-м курсами паллиативной ПХТ максимально составляют 0,8 баллов при высокой статистической значимости ($p=0,02$), что позволяет сделать вывод о том, что качество жизни пациентов с опухоля-

ми без первично-выявленного очага падает при росте болевого синдрома.

На рисунке 4 представлены показатели интенсивности боли и качество жизни у пациентов с опухолями без первично-выявленного очага.

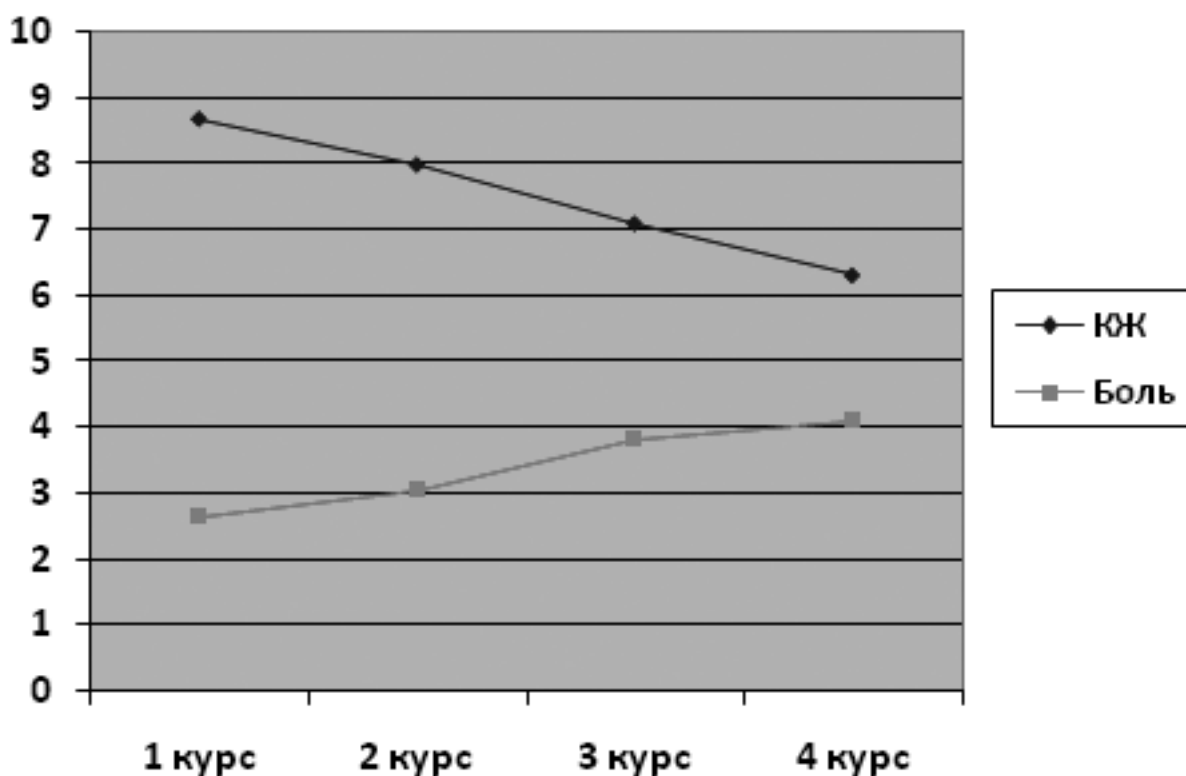


Рисунок 4 – Оценка интенсивности боли и качество жизни в целом у пациентов с опухолями без первично-выявленного очага на фоне проведения химиотерапии

Таким образом, математически показано, что при показателе качества жизни в целом, равного 6-7 баллов, и при возрастании интенсивности боли на 1-2 балла дальнейшее проведение паллиативной химиотерапии нецелесообразно, т.к. данные показатели наиболее наглядно позволяют судить об эффективности проведения химиотерапии пациентам.

Выводы. Качество жизни пациентов с опухолями без первично-выявленного очага на фоне проведения пал-

лиативной химиотерапии заметно снижается за счет таких показателей, как тошнота, рвота, снижение аппетита, слабость, усталость, снижение памяти, нарушение сна, беспокойство, необходимость в посторонней помощи.

Нецелесообразно проведение дальнейших курсов паллиативной химиотерапии при возрастании болевого синдрома на 1-2 балла при показателе качества жизни в целом, равного 6-7 баллам.

Список литературы

1. Комаров И.Г., Комов Д.В. Диагностическая и лечебная тактика при метастазах злокачественных опухолей без выявленного первичного очага. - М.: Триада-Х., 2002. - 136 с.
2. Зинченко С.В. Современные подходы к диагностике и лечению больных с метастазами злокачественных опухолей без выявленного первичного очага: диссертация доктора медицинских наук: 14.01.12 // ГУ "Российский онкологический научный центр РАМН". - М., 2011. - 222 с.
3. Doyle Derek Palliative medicine in Britain / Omega (USA). - 2007-2008. - 1. - P.77 - 88.
4. Бадалян Л.Г. Паллиативная химиотерапия рака: основные понятия и особенности // Вестник Хирургии Армении. - 2010. - №3. - С. 34 - 51.
5. Бейсенаева А.Р., Сирота В.Б. 2014 ©. Опросник для определения качества жизни инкурабельных пациентов на фоне проведения химиотерапии (QLQ-IP-CC) // Свидетельства о регистрации прав на объект авторского права: № 0164 от 22.01.16, № 0167 от 25.01.16, № 0166 от 25.01.16.

Тұжырым

Summary

А.Р. Бейсенаева, В.Б. Сирота, Д.Д. Дороган, А.А. Уйсин
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

A.R. Beisenayeva, V.B. Sirota, D.D. Dorogan, A.A. Uisin
Karaganda state medical university

**ПАЛЛИАТИВТІ ХИМИЯЛЫҚ ТЕРАПИЯ
ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ АЛҒАШҚЫ ОШАҒЫ
АНЫҚТАЛМАҒАН ІСІКТЕРІ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ ӨМІР
СҰРУ САПАСЫН АНЫҚТАУ**

**DETERMINATION of LIFE QUALITY of PATIENTS with
CANCER of UNKNOWN PRIMARY in the COURSE of
PALLIATIVE CHEMOTHERAPY**

Өмір сүру сапасын бағалау үшін науқастардан «Химиялық терапия жүргізу жағдайында (QLQ-IP-CC) инкурабельді науқастардың өмір сүру сапасын анықтауға арналған сауалнама» (А.Р.Бейсенаева, В. Б.Сирота, 2016 ©) арқылы сауалнама алынды. Сауалнама алғашқы ауру ошағы анықталмаған 70 науқастан алынды. Өмір сүру сапасының көрсеткіші 6-7 балды құраса және ауру қарқыны 1-2 балға артқан кезде паллиативті химиялық терапияны ары қарай жүргізу орынсыз екендігі математикалық тұрғыдан көрсетілген, себебі, аталмыш көрсеткіштер емделушілерге химиялық терапияны жүргізу тиімділігін шешуге мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: алғашқы анықталмай пайда болған ісіктер, паллиативті химиялық терапия, өмір сапасы.

To evaluate the quality of life the patients were inquired with the help of "Inquirer to determine incurable patients' life quality on the background of carrying out chemotherapy (QLQ-IP-CC)" (Beisenayeva A.R., Sirota V.B., 2016 ©). In total 70 patients with cancer of unknown primary were investigated. It was mathematically proved that in the case of life quality indicator of 6-7 points, and in the case of increasing of pain intensity 1-2 points more, the further carrying out of palliative chemotherapy is unreasonable, as the given indicators obviously let us estimate the efficiency of chemotherapy carrying out for the patients.

Keywords: tumors of unknown primary, palliative chemotherapy, quality of life.